APPROVED AUGUST 2026



TREATMENT PROTOCOLS BOOK 2

LOS SANTOS EMS AGENCY
PREHOSPITAL CARE TREATMENT

1 OBJECTIF 2
1.1 Exemple de protocole 2
2 CARDIOVASCULAIRE 3
2.1 Arrêt cardiaque non traumatique 3
2.2 Bradycardie 4
2.2 Tachycardie 5
2.3 Douleur thoracique 6
2.4 Œdème pulmonaire 7
3 URGENCES OBSTÉTRICALES 8
3.1 Accouchement 8
3.2 Complications liées à la grossesse 9
4 URGENCES ENVIRONNEMENTALES 10
4.1 Réaction allergique 10
4.2 Brûlure 11
4.3 Électrisation 12
4.4 Hyperthermie 13
4.5 Hypothermie 14
4.6 Morsure/piqûre venimeuse 15
5 NEUROLOGIE 16
5.1 Vertiges 16
5.2 Convulsions 17
5.3 Accident vasculaire cérébral 18
5.4 Syncope 19
6 TROUBLES RESPIRATOIRES 20
6.1 Obstruction des voies aériennes 20
6.2 Blessure par inhalation 21
6.3 Détresse respiratoire 22
7 TRAUMATISMES 23
7.1 Blessure par écrasement 23
7.2 Arrêt cardiaque traumatique 24
7.3 Hémorragie (membre) 25
7.4 Hémorragie (thorax/abdomen/pelvis) 26
7.5 Hémorragie (tête/cou) 27
7.6 Gestion de la douleur 28
8 TOXICOLOGIE 29
8.1 Overdose et intoxication 29
8.2 Exposition au monoxyde de carbone 30
9 MANOEUVRES GÉNÉRALES 31
9.1 Immobilisation du rachis 31
9.2 Retrait du casque 33
9.3 Évaluation de la tension (méthode palpatoire) 34
9.4 Évaluation de la glycémie 35
9.5 Ventilation par BAVU 36

1 OBJECTIF

Ces protocoles ne sont pas conçus comme des documents de traitement absolu, mais plutôt comme des principes et des directives suffisamment souples pour s'adapter à la complexité de la prise en charge des patients.

Aucun protocole ne peut être écrit pour couvrir toutes les situations qu'un EMT peut rencontrer, et les protocoles ne peuvent pas non plus se substituer au bon jugement et à l'expérience.

Chaque EMT commence par le début d'un protocole donné selon son niveau de certification et effectue les procédures dans l'ordre indiqué en faisant preuve d'un jugement à toute épreuve. Les EMT-Paramedics doivent effectuer les traitements et les procédures énumérés avant leurs sections respectives avant de passer à la section correspondant à leur niveau.

Les définitions relatives aux niveaux médicaux sont listés dans le livre 1 de la présente série.

1.1 Exemple de protocole

EMERGENCY MEDICAL TECHNICIAN

1. Protocole de niveau BLS.

EMT STOP

PARAMEDIC

2. Protocole de niveau ALS.

PARAMEDIC STOP

POINTS CLEFS

- Points clefs potentiels à la bonne réussite des manœuvres.

2 CARDIOVASCULAIRE

2.1 Arrêt cardiaque non traumatique

EMERGENCY MEDICAL TECHNICIAN

1. Débuter la réanimation cardio-pulmonaire (RCP).
2. Débuter la gestion des voies aériennes.
3. Débuter la ventilation avec oxygène à 15L/min.
4. Se munir et allumer le Défibrillateur Automatisé Externe (DAE).
5. Appliquer les patchs du DAE sur le torse nu du patient en maintenant des interruptions minimales des compressions thoraciques.
6. Connecter les patchs au DAE en écoutant les consignes vocales.
7. Continuer la RCP et ré-analyser toutes les deux (2) minutes et choquer comme indiqué.
8. Demander une assistance ALS et répéter la procédure en attendant.
9. Considérer le transport après trois (3) cycles de RCP et d'analyse du DAE.

EMT STOP

PARAMEDIC

10. Continuer la RCP et la défibrillation en maintenant des interruptions minimales des compressions thoraciques.
11. Si un DAE est en activité, effectuer la transition du DAE vers un moniteur ALS (tel que le LIFEPAK 15). Utiliser le paramètre maximal en joule lors de la défibrillation.
12. Effectuer une décompression pour tout pneumothorax suspecté, tel que nécessaire.
13. Établir un accès IV.
14. Administrer de l'Épinéphrine 1 mg IV. Répéter toutes les 3-5 minutes jusqu'au retour à une circulation spontanée.
15. Effectuer un contrôle avancé des voies aériennes.
16. Obtenir l'état de la glycémie et traiter tel que nécessaire.
17. Si le rythme est une fibrillation ventriculaire/tachycardie ventriculaire, administrer:
    - OPTION A: Amiodarone 300 mg (6mL) IV/IO
    - Répéter pour 150 mg (3 ml) d'Amiodarone IV/IO une fois au besoin après deux défibrillateurs supplémentaires, dose totale maximale de 450 mg.
18. Si sur scène depuis 20 minutes, considérer une prise de contact avec l'OLMC ou transporter.

PARAMEDIC STOP

POINTS CLEFS

- N'interrompez pas les compressions pour mettre en place la gestion des voies aériennes.
- Réduisez au minimum les interruptions des compressions pour mettre en place un dispositif mécanique de RCP (LUCAS, ...).
- Un DAE doit être mis en place dès que possible sans interrompre les compressions.

2.2 Bradycardie

EMERGENCY MEDICAL TECHNICIAN

1. Débuter l'ABCD et vérifier les signes vitaux.
2. Débuter la gestion des voies aériennes et une oxygénothérapie si nécessaire.
3. Demander une assistance ALS, ne pas retarder le transport.

EMT STOP

PARAMEDIC

4. Débuter la surveillance cardiaque.
5. Réaliser, enregistrer et évaluer un électrocardiogramme (ECG) à 12 dérivations.
6. Administrer de l'Atropine 1 mg IV.

PARAMEDIC STOP

POINTS CLEFS

2.2 Tachycardie

EMERGENCY MEDICAL TECHNICIAN

1. Débuter l'ABCD et vérifier les signes vitaux.
2. Débuter la gestion des voies aériennes et une oxygénothérapie si nécessaire.
3. Demander une assistance ALS, ne pas retarder le transport.

EMT STOP

PARAMEDIC

4. Débuter la surveillance cardiaque.
5. Réaliser, enregistrer et évaluer un électrocardiogramme (ECG) à 12 dérivations.
6. Administrer Midazolam 5 mg (1 mL) IV/IO pour sédation avant cardioversion.
7. Effectuer une cardioversion synchronisée à 100 joules au moyen du LIFEPAK 15.
8. Répéter à 200, 300 et 360 joules si nécessaire.

PARAMEDIC STOP

POINTS CLEFS

2.3 Douleur thoracique

EMERGENCY MEDICAL TECHNICIAN

1. Débuter l'ABCD et vérifier les signes vitaux.
2. Débuter la gestion des voies aériennes et une oxygénothérapie si nécessaire.
3. Placer le patient dans une position confortable.
4. Basculer sur les protocoles liés à la gestion de la douleur si nécessaire.
5. Administrer de l'Aspirine 325 mg à croquer PO, si disponible.
6. Demander une assistance ALS, ne pas retarder le transport.

EMT STOP

PARAMEDIC

7. Débuter la surveillance cardiaque.
8. Réaliser, enregistrer et évaluer un électrocardiogramme (ECG) à 12 dérivations.
9. Établir l'accès intraveineux.
10. Vérifier les signes vitaux toutes les 2-3 minutes.
11. Administrer de la Nitroglycérine 0.4 mg SL toutes les cinq (5) minutes, trois (3) doses maximum.
12. En cas de nausées/vomissements ;
    - Administrer de l'Ondansetron 4 mg IV/IM.

PARAMEDIC STOP

POINTS CLEFS

- L'aspirine ne doit pas être administrée aux patients présentant une hypersensibilité connue à l'aspirine.
- Si disponible, le Fentanyl doit être préféré à la Morphine pour la gestion de la douleur.

2.4 Œdème pulmonaire

EMERGENCY MEDICAL TECHNICIAN

1. Débuter l'ABCD et vérifier les signes vitaux.
2. Débuter la gestion des voies aériennes et une oxygénothérapie (15L/min) si nécessaire.
3. Administrer de l'Aspirine 325 mg à croquer PO, si disponible et qu'une douleur thoracique est ressentie.
4. Demander une assistance ALS, ne pas retarder le transport.

EMT STOP

PARAMEDIC

5. Débuter la surveillance cardiaque.
6. Réaliser, enregistrer et évaluer un électrocardiogramme (ECG) à 12 dérivations.
7. Établir l'accès intraveineux.
8. Vérifier les signes vitaux toutes les 2-3 minutes.
9. Administrer de la Nitroglycérine 0.4 mg SL toutes les cinq (5) minutes, trois (3) doses maximum.

PARAMEDIC STOP

POINTS CLEFS

3 URGENCES OBSTÉTRICALES

3.1 Accouchement

EMERGENCY MEDICAL TECHNICIAN

1. Débuter l'ABCD et vérifier les signes vitaux.
2. Débuter la gestion des voies aériennes et une oxygénothérapie si nécessaire.
3. Vérifier le couronnement si la mère sent des contractions, l'urgence de pousser ou à la sensation d'un mouvement au niveau de son abdomen. Si le couronnement est présent, l'accouchement est imminent.
4. Si l'accouchement a commencé, traiter de façon appropriée.
5. Si l'accouchement n'a pas commencé, placez la patiente en position couchée sur son côté gauche.
6. Demander une assistance ALS si l'accouchement est imminent.
7. Transporter.

EMT STOP

PARAMEDIC

8. Débuter la surveillance cardiaque.
9. Réaliser, enregistrer et évaluer un électrocardiogramme (ECG) à 12 dérivations.
10. Établir l'accès intraveineux.
11. En cas d'hémorragie post-partum ;
    - Administrer Normal Saline 1L IV.
    - Répéter une fois si le saignement persiste.

PARAMEDIC STOP

POINTS CLEFS

3.2 Complications liées à la grossesse

EMERGENCY MEDICAL TECHNICIAN

1. Débuter l'ABCD et vérifier les signes vitaux.
2. Débuter la gestion des voies aériennes et une oxygénothérapie si nécessaire.
3. Transporter dès que possible.

EMT STOP

PARAMEDIC

4. Débuter la surveillance cardiaque.
5. Réaliser, enregistrer et évaluer un électrocardiogramme (ECG) à 12 dérivations.
6. Établir l'accès intraveineux.
7. En cas d'hémorragie post-partum ;
    - Administrer Normal Saline 1L IV.

PARAMEDIC STOP

POINTS CLEFS

4 URGENCES ENVIRONNEMENTALES

4.1 Réaction allergique

EMERGENCY MEDICAL TECHNICIAN

1. Débuter l'ABCD et vérifier les signes vitaux.
2. Débuter la gestion des voies aériennes.
3. Débuter l'oxygénothérapie. (15L/min)
4. Vérifier les rythmes circulatoire et respiratoire, s'il est anormal considérer l'injection d'Épinéphrine IM par auto-injecteur (EpiPen).
5. Demander une assistance ALS ou transporter.
6. Si les symptômes continuent, considérer une nouvelle injection d'Épinéphrine IM (2 doses maximum).

EMT STOP

PARAMEDIC

7. Débuter la surveillance cardiaque.
8. Réaliser, enregistrer et évaluer un électrocardiogramme (ECG) à 12 dérivations.
9. Établir l'accès intraveineux.
10. En cas de démangeaisons ;
    - Administrer Diphenhydramine 50mg (1mL) IV/IM.

PARAMEDIC STOP

POINTS CLEFS

- Ne pas retarder le transport, même en cas d'attente pour une deuxième dose d'Épinéphrine.
- Après l'administration d'Épinéphrine, surveillez attentivement le patient toutes les 3-5 minutes pour constater toute évolution des symptômes.
- L'anaphylaxie peut mettre en danger la vie du patient si elle est associée avec une exposition passée à:
    - La drogue ou des médicaments
    - Agent allergène (piqûre d'abeille ou venin d'insecte)
    - De la nourriture (cacahuètes, fruits de mer, ...)

4.2 Brûlure

EMERGENCY MEDICAL TECHNICIAN

1. Éloigner la victime de la source de combustion si possible.
2. Débuter l'ABCD et vérifier les signes vitaux.
3. Débuter la gestion des voies aériennes et l'oxygénothérapie (15L/min) si nécessaire.
4. Retirer les vêtements qui n'adhèrent pas à la peau du patient.
5. Si possible, retirer les bijoux et autres objets contraignants sur les membres brûlés.
6. Si possible, appliquez de l'eau froide sur la brûlure et couvrir avec un pansement stérile non adhérent.
7. Pour les brûlures avec un degré de lésion supérieur, appliquer des compresses médicales BURNAID.
8. Irriguer immédiatement les brûlures oculaires avec une solution physiologique (Normal Saline) ou de l'eau.

EMT STOP

PARAMEDIC

9. Effectuer une gestion des voies aériennes avancée si nécessaire.
10. Débuter la surveillance cardiaque.
11. Établir l'accès intraveineux.
12. Pour les brûlures partielles et complètes (2e degré ou plus) > 20% surface corporelle ;
    - Administrer Normal Saline 1L IV/IO.
13. Si accès intraveineux impossible sur un patient alerte ;
    - Administrer Lidocaine 2% 40mg (20mg/mL) IO.

PARAMEDIC STOP

POINTS CLEFS

- Assurer la sécurité des lieux et la décontamination des patients en cas de brûlures chimiques ou d'exposition HAZMAT:
    - Pour les brûlures chimiques liquides: rincer abondamment à l'eau ou avec une solution physiologique (Normal Saline), idéalement pendant au moins 20 minutes.
    - Pour les brûlures par poudre sèche: brosser la poudre avant de rincer.
    - Faire preuve de prudence pour éviter la propagation du contaminant aux zones non touchées (en particulier d'un œil à l'autre).
    - Si l'on soupçonne la présence de matières dangereuses, avertir l'hôpital de destination pour permettre une décontamination appropriée.
- La saturation en oxygène peut être faussement élevée en cas de suspicion d'inhalation de fumée.

4.3 Électrisation

EMERGENCY MEDICAL TECHNICIAN

1. S'il est impossible de l'éteindre, éloigner la victime de la source électrique si possible.
2. Débuter l'ABCD et vérifier les signes vitaux.
3. Débuter la gestion des voies aériennes et l'oxygénothérapie (15L/min) si nécessaire.
4. En cas d'arrêt cardiaque, voir le protocole approprié.
5. En cas de brûlure, voir le protocole approprié.
6. Retirer les vêtements et bijoux de la victime si possible.
7. Contacter une unité ALS ou transporter dès que possible.

EMT STOP

PARAMEDIC

8. Effectuer une gestion des voies aériennes avancée si nécessaire.
9. Débuter la surveillance cardiaque.
10. Établir l'accès intraveineux.
11. En cas de nausées ou vomissements ;
    - Administrer Ondansetron 4mg IV/IM, peut être répété 1x après 15 minutes.

PARAMEDIC STOP

POINTS CLEFS

- Ne touchez pas le patient tant que vous n'avez pas coupé la source d'électricité. Le courant électrique peut être conduit par l'eau et la peau. Assurez-vous que la zone entourant le patient est sèche avant de vous approcher de lui.
- L'électrocution peut entraîner une tachycardie, une fibrillation ventriculaire, une asystolie ou d'autres arythmies. Cependant, si le rythme cardiaque du patient est régulier lors de l'évaluation, il est peu probable qu'il développe une arythmie.

4.4 Hyperthermie

EMERGENCY MEDICAL TECHNICIAN

1. Débuter l'ABCD et vérifier les signes vitaux.
2. Débuter la gestion des voies aériennes et une oxygénothérapie si nécessaire.
3. Aider le patient à se déplacer vers une zone réfrigérée, si possible.
4. Aider le patient à retirer ses vêtements extérieurs (veste, pull, ...).
5. Si le patient est conscient et en état de boire sans assistance, lui donner de l'eau, si possible.
6. Si l'état mental du patient est altéré:
    - Évaluer le taux de glucose dans le sang du patient et traiter si nécessaire.
    - Demander une assistance ALS.
7. Transporter.

EMT STOP

PARAMEDIC

8. Établir l'accès intraveineux.
9. Si le patient est incapable de boire ;
    - Administrer Normal Saline 1L IV.

PARAMEDIC STOP

POINTS CLEFS

- Ne pas abaisser agressivement la température corporelles.
- Le refroidissement de la température corporelle du patient ne doit PAS retarder le transport.
- Les patients en situation d'urgence thermique présentant des signes de choc doivent être traités et transportés rapidement.
- Populations particulières présentant un risque élevé d'évolution défavorable:
    - Personnes âgées
    - Patients présentant des comorbidités, prenant des diurétiques ou des médicaments psychiatriques
    - Athlètes

4.5 Hypothermie

EMERGENCY MEDICAL TECHNICIAN

1. Débuter l'ABCD et vérifier les signes vitaux.
2. Débuter la gestion des voies aériennes et une oxygénothérapie si nécessaire.
3. Aider le patient à se déplacer vers une zone chauffée, si possible.
4. Si le patient est conscient et en état de boire sans assistance, lui donner une boisson tiède, si possible.
5. Considérations spéciales:
    - Blessures liées au froid localisées:
        - Retirer les vêtements et les bijoux de la zone affectée.
        - Protéger la zone affectée.
    - Hypothermie généralisée:
        - Vérifier le pouls du patient pendant une minute et débuter la RCP si nécessaire.
        - Retirer tout vêtement mouillé et les bijoux du patient.
        - Placer des poches de chaud instantanées au niveau de l'aine, du cou et sur les côtés de la poitrine du patient.
        - Recouvrir le patient avec une/des couverture(s) chauffante(s).
6. En cas d'état mental altéré:
    - Vérifier le taux de glucose dans le sang.
    - Demander une assistance ALS.
7. Transporter.

EMT STOP

PARAMEDIC

8. Effectuer une gestion des voies aériennes avancée si nécessaire.
9. Débuter la surveillance cardiaque.
10. Réaliser, enregistrer et évaluer un électrocardiogramme (ECG) à 12 dérivations.
11. Établir l'accès intraveineux.

PARAMEDIC STOP

POINTS CLEFS

- Hypothermie généralisée:
    - Les signes vitaux peuvent être extrêmement difficiles à obtenir.
    - Couvrir la tête aide efficacement à réduire la perte de chaleur.
    - Une manipulation brusque du patient peut mener à une dysrythmie ou à un arrêt cardiaque.

4.6 Morsure/piqûre venimeuse

EMERGENCY MEDICAL TECHNICIAN

1. Débuter l'ABCD et vérifier les signes vitaux.
2. Débuter la gestion des voies aériennes et une oxygénothérapie si nécessaire.
3. Garder le patient calme et limiter ses mouvements.
4. Positionner le membre affecté au niveau ou en dessous du niveau du cœur.
5. En cas de morsure de serpent ;
    - Immobiliser la zone touchée à l'aide d'une attelle.
    - Surélever le membre touché à hauteur du cœur.
6. En cas de piqûre d'insecte ;
    - Retirer le dard s'il est visible.
    - Refroidir la zone.
7. En cas de piqûre d'un animal marin ;
    - Retirer l'ardillon si nécessaire.
    - Tremper la zone dans de l'eau chaude si disponible.

EMT STOP

PARAMEDIC

8. Effectuer une gestion des voies aériennes avancée si nécessaire.
9. Débuter la surveillance cardiaque.
10. Établir l'accès intraveineux.
11. En cas de nausées ou vomissements ;
    - Administrer Ondansetron 4mg IV/IM, peut être répété 1x après 15 minutes.

PARAMEDIC STOP

POINTS CLEFS

- Retirez le dard en grattant la peau du patient avec le bord d'une surface plane (carte de crédit ou similaire). N'essayez pas de retirer le dard avec vos ongles ou une pince à épiler, car cela pourrait libérer davantage de venin.

5 NEUROLOGIE

5.1 Vertiges

EMERGENCY MEDICAL TECHNICIAN

1. Débuter l'ABCD et vérifier les signes vitaux.
2. Débuter la gestion des voies aériennes.
3. Débuter l'oxygénothérapie.
4. Vérifier la glycémie.
5. Demander une assistance ALS ou transporter.

EMT STOP

PARAMEDIC

6. Débuter la surveillance cardiaque.
7. Établir l'accès intraveineux.
8. En cas de nausées ou vomissements ;
    - Administrer Ondansetron 4mg IV/IM, peut être répété 1x après 15 minutes.

PARAMEDIC STOP

POINTS CLEFS

- Le terme « vertige » est souvent utilisé pour décrire deux sensations différentes : le vertige et l'étourdissement. Le vertige est la sensation qu'une personne ou son environnement bouge alors qu'il n'y a aucun mouvement réel. Les personnes décrivent souvent cette sensation comme une impression de tourner, de tomber, de basculer ou de perdre l'équilibre. Elle est souvent associée à des nausées/vomissements. L'étourdissement peut entraîner une sensation de malaise ou une syncope, et le patient rapporte souvent une amélioration en position couchée.

5.2 Convulsions

EMERGENCY MEDICAL TECHNICIAN

1. Protéger le patient pour prévenir toute blessure.
2. Débuter l'ABCD et vérifier les signes vitaux.
3. Débuter la gestion des voies aériennes en suivant ces considérations spéciales:
    - Positionner le patient de manière à maintenir la perméabilité des voies respiratoires.
    - Ne pas utiliser de canule de guedel durant les convulsions.
4. Débuter l'oxygénothérapie.
5. Éviter les restrictions inutiles ou excessives.
6. Traiter les possibles blessures si nécessaire.
7. Vérifier la glycémie.
8. Demander une assistance ALS si le patient convulse au moment de l'évaluation primaire.
9. Transporter.

EMT STOP

PARAMEDIC

10. Établir l'accès intraveineux.
11. Si le patient est sujet à des convulsions généralisées qui sont en cours ou récurrentes ET si le patient est actuellement en train de convulser, administrer:
    - Midazolam 10mg (2 mL) IM/IN
    - Si accès intraveineux déjà établi : Midazolam 5mg (1 mL) IV/IO, répéter 1x après 2 minutes.
12. Effectuer une gestion des voies aériennes avancée si nécessaire.
13. Débuter la surveillance cardiaque.

PARAMEDIC STOP

POINTS CLEFS

- Les convulsions peuvent être causées par des problèmes médicaux sous-jacents ou l'ingestion de substances toxiques. Faites tout votre possible pour obtenir les antécédents médicaux du patient et déterminer tous les médicaments/stupéfiants qu'il a pu prendre.

5.3 Accident vasculaire cérébral

EMERGENCY MEDICAL TECHNICIAN

1. Débuter l'ABCD et vérifier les signes vitaux.
2. Débuter la gestion des voies aériennes et l'oxygénothérapie si nécessaire.
3. Vérifier la glycémie.
4. Transporter.

EMT STOP

PARAMEDIC

5. Ne PAS retarder le transport.
6. Débuter la surveillance cardiaque.
7. Établir l'accès intraveineux.

PARAMEDIC STOP

POINTS CLEFS

- Dans la mesure du possible, transportez les patients soupçonnés d'avoir subi un AVC avec la tête du lit surélevée de 30 à 45 degrés. Cela réduit le risque d'aspiration et diminue également l'élévation de la pression intracrânienne.

5.4 Syncope

EMERGENCY MEDICAL TECHNICIAN

1. Débuter l'ABCD et vérifier les signes vitaux.
2. Débuter la gestion des voies aériennes et l'oxygénothérapie si nécessaire.
3. Vérifier la glycémie.
4. Demander une assistance ALS ou transporter.

EMT STOP

PARAMEDIC

5. Établir l'accès IV.
6. En cas de signes de déshydratation :
    - Administrer Normal Saline 1L IV.
7. Débuter la surveillance cardiaque.
8. Réaliser, enregistrer et évaluer un électrocardiogramme (ECG) à 12 dérivations.

PARAMEDIC STOP

POINTS CLEFS

6 TROUBLES RESPIRATOIRES

6.1 Obstruction des voies aériennes

EMERGENCY MEDICAL TECHNICIAN

1. Débuter l'ABCD et vérifier les signes vitaux.
2. Débuter la gestion des voies aériennes.
3. Débuter l'oxygénothérapie.
4. En cas d'obstruction par un corps étranger :
    - Si le patient est incapable de parler mais conscient, effectuer 5 compressions abdominales ; réévaluer la situation.
        - Si le patient perd connaissance, l'allonger sur le sol et commencer les compressions thoraciques.
    - Si le patient est inconscient, commencer la RCP pendant 2 minutes.
        - Demander une ressource ALS et se référer aux arrêts cardiaques non-traumatiques.
        - Transporter.

EMT STOP

PARAMEDIC

5. Effectuez une laryngoscopie directe pour visualiser l'obstruction potentielle lorsque cela est indiqué :
    - Retirez le corps étranger visible à l'aide d'une pince de Magill.
6. Débuter la surveillance cardiaque.
7. Tenir compte des symptômes spécifiques :
    - En cas de suspicion d'anaphylaxie, traiter conformément au protocole adéquat.
8. En cas de stridor :
    - Administrer 5 mg (5 ml) d'épinéphrine (solution à 1 mg/ml).
    - Répéter x1 toutes les 10 min.
    - Se préparer à gérer les voies respiratoires si l'état du patient se détériore.
9. En cas de gonflement visible des voies respiratoires/de la langue :
    - Épinéphrine (1 mg/mL) administrer 0,5 mg (0,5 mL) IM.
    - Répéter toutes les 10 min, maximum 3 doses au total.

PARAMEDIC STOP

POINTS CLEFS

6.2 Blessure par inhalation

EMERGENCY MEDICAL TECHNICIAN

1. Débuter l'ABCD et vérifier les signes vitaux.
2. Débuter la gestion des voies aériennes.
3. Débuter l'oxygénothérapie.
4. Traiter toute potentielle brûlure.
5. Évaluer le taux de monoxyde de carbone (SpCO) du patient, si possible.
6. Demander une assistance ALS.
7. Transporter.

EMT STOP

PARAMEDIC

8. Effectuer une gestion des voies aériennes avancée si nécessaire.
9. Établir l'accès intraveineux.
10. Administrer Normal Saline 2L IV.
11. Débuter la surveillance cardiaque.

PARAMEDIC STOP

POINTS CLEFS

6.3 Détresse respiratoire

EMERGENCY MEDICAL TECHNICIAN

1. Débuter l'ABCD et vérifier les signes vitaux.
2. Administrer de l'oxygène tel que:
    - En condition de détresse respiratoire, administrer de l'oxygène et aider le patient à garder une position confortable
    - En condition d'insuffisance respiratoire, assister la ventilation à un rythme de 10 insufflations/minute via BAVU.
3. En cas d'overdose suspectée, se référer au chapitre adéquat.
4. Demander une assistance ALS ou transporter.

EMT STOP

PARAMEDIC

5. Effectuer une gestion des voies aériennes avancée si nécessaire.
6. Effectuer une décompression pour tout pneumothorax suspecté, tel que nécessaire.
7. Débuter une surveillance cardiaque au moyen du LIFEPAK 15.
8. Établir l'accès intraveineux.
9. Vérifier les signaux vitaux toutes les 2-3 minutes.

PARAMEDIC STOP

POINTS CLEFS

- Envisager de porter un masque chirurgical au cours des soins de patients souffrant de détresse respiratoire d'étiologie incertaine, qui peut être infectieuse.

7 TRAUMATISMES

7.1 Blessure par écrasement

EMERGENCY MEDICAL TECHNICIAN

1. Débuter l'ABCD et vérifier les signes vitaux.
2. Débuter l'oxygénothérapie.
3. Si nécessaire, prioriser l'immobilisation.
4. Recouvrir la victime avec une couverture de survie.
5. Demander une assistance ALS ou transporter.

EMT STOP

PARAMEDIC

6. Effectuer une gestion des voies aériennes avancée si nécessaire.
7. Débuter une surveillance cardiaque au moyen du LIFEPAK 15.
8. Établir l'accès intraveineux.
9. Administrer Normal Saline 1L IV.
    - Répéter une fois pour un total de 2L.
10. Vérifier les signaux vitaux toutes les 2-3 minutes.
11. Pour les patients dans les 30 minutes suivant une hémorragie incontrôlée au niveau des membres malgré l'application d'un moyen de compression et d'un garrot :
    - Tranexamic Acid (TXA) 1g dilué dans 50-100mL Normal Saline IV/IO.

PARAMEDIC STOP

POINTS CLEFS

7.2 Arrêt cardiaque traumatique

EMERGENCY MEDICAL TECHNICIAN

1. Contrôler immédiatement les hémorragies importantes.
2. Débuter la gestion des voies aériennes.
3. Débuter la ventilation avec oxygène à 15L/min.
4. Débuter les compressions thoraciques.
5. Se munir et allumer le Défibrillateur Automatisé Externe (DAE).
6. Appliquer les patchs du DAE sur le torse nu du patient en maintenant des interruptions minimales des compressions thoraciques.
7. Connecter les patchs au DAE en écoutant les consignes vocales.
8. Continuer la RCP et ré-analyser toutes les deux (2) minutes et choquer comme indiqué.
9. Demander une assistance ALS et répéter la procédure en attendant.
10. Considérer le transport après trois (3) cycles de RCP et d'analyse du DAE.

EMT STOP

PARAMEDIC

11. Continuer la RCP et la défibrillation en maintenant des interruptions minimales des compressions thoraciques.
12. Si un DAE est en activité, effectuer la transition du DAE vers un moniteur ALS (tel que le LIFEPAK 15). Utiliser le paramètre maximal en joule lors de la défibrillation.
13. Effectuer une décompression pour tout pneumothorax suspecté, tel que nécessaire.
14. Établir un accès IV sur la route.
15. Administrer Normal Saline 2L IV.
    - Administrer par deux accès si possible.

PARAMEDIC STOP

POINTS CLEFS

7.3 Hémorragie (membre)

EMERGENCY MEDICAL TECHNICIAN

1. Appliquez une pression directe sur la plaie à l'aide d'un bandage :
    - Une gaze hémostatique peut être appliquée.
    - Maintenez une pression continue ou appliquez un pansement compressif sur la plaie.
2. Appliquez un tourniquet à 5 à 7 cm au-dessus de la plaie si :
    - La pression directe ne permet pas de contrôler le saignement.
    - Amputation ou quasi-amputation du membre.
    - Saignement important inaccessible (ex : membre coincé).
    - Saignement important provenant d'un objet encore présent (ex : couteau).
    - Lors d'un incident impliquant plusieurs victimes.
3. Débuter l'ABCD.
4. Débuter la gestion des voies aériennes et l'oxygénothérapie.
5. Immobilisez les membres blessés si nécessaire. Surélevez le membre et appliquez des compresses froides. Couvrez les plaies ouvertes avec un pansement stérile. Vérifiez à nouveau les fonctions motrices/la circulation toutes les 5 minutes.
6. Demander une ressource ALS ou transporter.

EMT STOP

PARAMEDIC

7. Débuter une gestion des voies aériennes avancée si nécessaire.
8. Débuter la surveillance cardiaque.
9. Établir l'accès intraveineux.
10. Si pression artérielle <90 :
    - Administrer 1L Normal Saline IV.

PARAMEDIC STOP

POINTS CLEFS

- Mise en place du tourniquet :
    - Noter l'heure et l'emplacement du ou des tourniquets.
        - L'heure à laquelle le garrot a été appliqué doit être communiquée au personnel hospitalier qui prend en charge le patient.
    - Ne pas placer le garrot sur une articulation.
    - Le membre sur lequel le garrot est placé doit rester exposé.
    - Ne pas retirer le garrot sans l'accord d'un médecin.
- Le traitement des hémorragies importantes est toujours prioritaire sur l'évaluation primaire.
- Si le saignement traverse un pansement, le recouvrir avec un second.

7.4 Hémorragie (thorax/abdomen/pelvis)

EMERGENCY MEDICAL TECHNICIAN

1. Stabiliser la colonne vertébrale et toute fracture suspectée.
2. Effectuer une pression directe sur la/les plaie(s).
3. Si nécessaire, appliquer un pansement occlusif.
4. Couvrez tout organe exposé et éviscéré avec une gaze humide imprégnée de solution saline.
5. Débuter l'ABCD.
6. Débuter la gestion des voies aériennes et l'oxygénothérapie.
7. Demander une ressource ALS ou transporter.

EMT STOP

PARAMEDIC

8. Débuter une gestion des voies aériennes avancée si nécessaire.
9. Débuter la surveillance cardiaque.
10. Établir l'accès intraveineux.
11. Administrer 1L Normal Saline IV.

PARAMEDIC STOP

POINTS CLEFS

- Le traitement des hémorragies importantes est toujours prioritaire sur l'évaluation primaire.
- Si le saignement traverse un pansement, le recouvrir avec un second.

7.5 Hémorragie (tête/cou)

EMERGENCY MEDICAL TECHNICIAN

1. Si possible, immobiliser le patient.
2. Effectuer une pression directe sur la/les plaie(s).
3. Si un corps étranger est présent :
    - Le couvrir avec une gaze humide.
4. Si blessure aux yeux :
    - Les couvrir avec un pansement imbibé de sérum physiologique.
5. Débuter l'ABCD.
6. Débuter la gestion des voies aériennes et l'oxygénothérapie.
7. Demander une ressource ALS ou transporter.

EMT STOP

PARAMEDIC

8. Débuter une gestion des voies aériennes avancée si nécessaire.
9. Débuter la surveillance cardiaque.
10. Établir l'accès intraveineux.
11. Administrer 1L Normal Saline IV.

PARAMEDIC STOP

POINTS CLEFS

- Le traitement des hémorragies importantes est toujours prioritaire sur l'évaluation primaire.
- Si le saignement traverse un pansement, le recouvrir avec un second.

7.6 Gestion de la douleur

EMERGENCY MEDICAL TECHNICIAN

1. Si 1 à 3 sur l'échelle de la douleur :
    - Ibuprofen 600 mg PO, 1x.
    - Poches de glace.
    - Distraction.
    - Position confortable.

2. Pour les douleurs au-dessus de 4, demander une ressource ALS.

EMT STOP

PARAMEDIC

3. Si 4 à 7 sur l'échelle de la douleur :
    - Ketorolac 15 mg (1 mL) IV/IO, ou ;
    - Ketorolac 30 mg (2 mL) IM.

4. Si supérieur à 7 sur l'échelle de la douleur :
    - Fentanyl 50mcg (1mL) IV/IM/IN, répéter toutes les 5 minutes pour dose maximum de 150mcg, ou ;
    - Morphine 4mg (1mL) IV/IO/IM, répéter toutes les 5 minutes pour dose maximum de 12mg.

PARAMEDIC STOP

POINTS CLEFS

- Contre-indications pour le Ketorolac :
    - Hémorragie.
    - Respiration sifflante.
    - Traumatisme crânien.
    - Grossesse.

- Contre-indications pour le Fentanyl :
    - Accouchement.

- Contre-indications pour la Morphine :
    - Hypotension.
    - Accouchement.

8 TOXICOLOGIE

8.1 Overdose et intoxication

EMERGENCY MEDICAL TECHNICIAN

1. Débuter l'ABCD et vérifier les signes vitaux.
2. Débuter la gestion des voies aériennes.
3. Débuter l'oxygénothérapie si nécessaire.
4. En cas d'overdose suspectée aux opioïdes :
    - Naloxone 2 mg IN (1 mg par narine) ou,
    - Naloxone 2 mg IM ou,
    - Dose maximale (toutes voies) : 8 mg.
5. Pour toute autre intoxication :
    - Documenter les impressions générales et ne pas retarder le transport.
6. Demander une assistance ALS ou transporter.

EMT STOP

PARAMEDIC

7. Effectuer une gestion des voies aériennes avancée si nécessaire.
8. Débuter une surveillance cardiaque au moyen du LIFEPAK 15.
9. Établir l'accès intraveineux.
10. En cas d'overdose suspectée aux opioïdes :
    - Administrer Naloxone 0,8 mg à 2 mg IV.
        - Se renseigner sur une potentielle injection précédente en cas de transfert BLS à ALS.
11. Vérifier les signaux vitaux toutes les 2-3 minutes.
12. Envisager une capnographie pour surveiller la ventilation.

PARAMEDIC STOP

POINTS CLEFS

8.2 Exposition au monoxyde de carbone

EMERGENCY MEDICAL TECHNICIAN

1. Vérifier la sûreté de la scène d'intervention.
2. Éloigner le patient de la source de monoxyde de carbone.
3. Débuter l'ABCD et vérifier les signes vitaux.
4. Débuter la gestion des voies aériennes.
5. Débuter l'oxygénothérapie. (15L/min).
6. Si un détecteur de monoxyde de carbone est disponible, envisager de mesurer le taux de CO.
7. Demander une assistance ALS ou transporter.

EMT STOP

PARAMEDIC

8. Effectuer une gestion des voies aériennes avancée si nécessaire.
9. Débuter une surveillance cardiaque au moyen du LIFEPAK 15.

PARAMEDIC STOP

POINTS CLEFS

9 MANOEUVRES GÉNÉRALES

9.1 Immobilisation du rachis

PRINCIPES

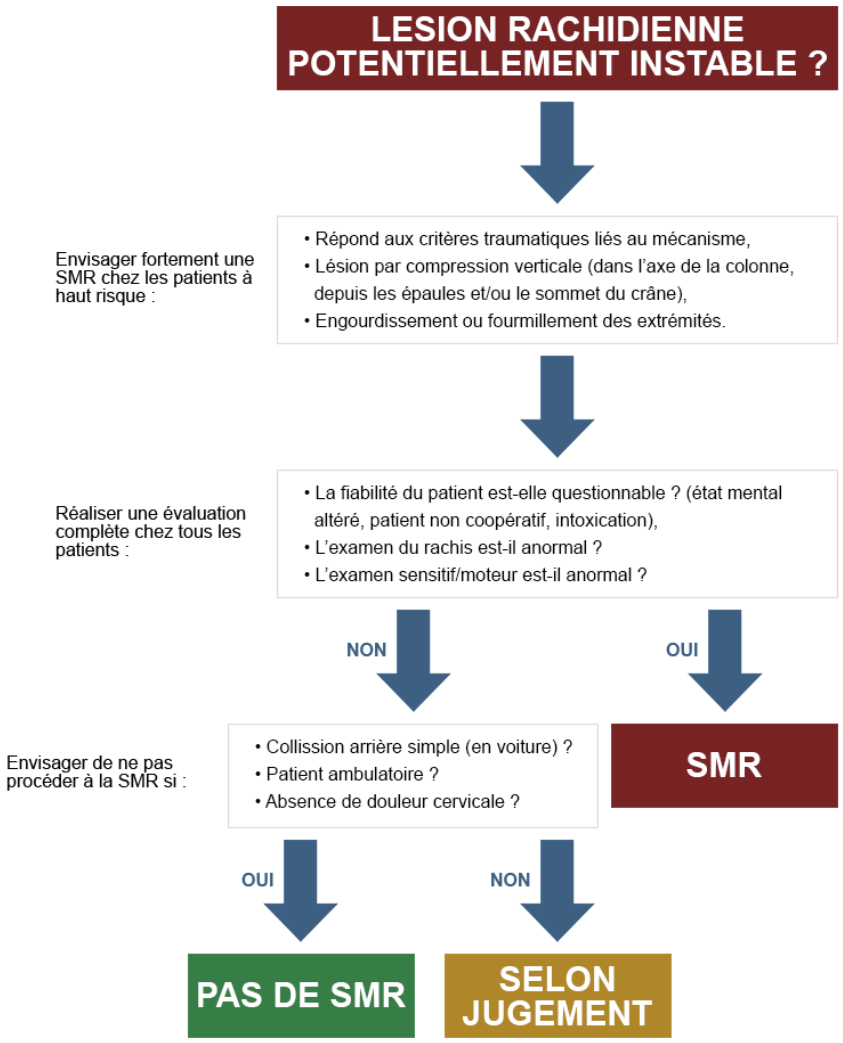
La restriction des mouvements du rachis (SMR, Spinal Motion Restriction) désigne la procédure permettant de prendre en charge les patients présentant des lésions vertébrales potentiellement instables. Elle comprend, notamment, la limitation des mouvements du patient, la prévention de lésions supplémentaires au niveau de la colonne vertébrale ; et une réévaluation régulière des fonctions motrices et sensorielles.

1. La SMR cherche à maintenir une position neutre et alignée de la colonne vertébrale pendant le traitement et le transport du patient.
2. La SMR nécessite une stabilisation de la tête, du cou et du torse du patient.
3. Si un patient ne présente aucun signe neurologique, la SMR peut toutefois être envisagée si l'on suspecte une lésion médullaire instable.
4. Un collier cervical seul ne constitue pas une SMR adéquate.
5. La planche dorsale peut constituer un moyen de faciliter la stabilisation de la colonne vertébrale, mais ne présente aucun avantage lorsque le patient est installé sur le brancard, et peut causer des préjudices (douleur, notamment).
6. Une planche dorsale ne doit pas être utilisée sur un patient ambulatoire (debout et/ou marchant lors de l'arrivée sur scène).
7. Un examen de la colonne vertébral anormal correspond à toute déformation ou sensibilité le long de la colonne vertébrale.

DIRECTIVES

1. Tout patient victime d'un traumatisme, y compris un patient ambulatoire, doit faire l'objet d'une évaluation. Si l'un des éléments de l'évaluation s'avère positif, une SMR est indiquée.
2. Tout patient initialement placé en SMR par un intervenant de niveau BLS, puis transféré vers un intervenant de niveau ALS, doit être réévalué.
3. L'examen neurologique doit comprendre :
    - Recherche de troubles sensitifs (paresthésies) au niveau des quatre membres.
    - Évaluation de la motricité des quatre extrémités au moyen de mouvements actifs, notamment :
        - Extension et flexion du poignet et des doigts,
        - Flexion plantaire et dorsiflexion du pied.
    - Une réévaluation neurologique fréquente.
4. Tous les éléments de l'anamnèse et de l'examen clinique doivent être inscrits dans l'Electronic Patient Care Report (ePCR).

ALGORITHME


LESION RACHIDIENNE POTENTIELLEMENT INSTABLE ?
Envisager fortement une SMR chez les patients à haut risque :
• Répond aux critères traumatiques liés au mécanisme,
• Lésion par compression verticale (dans l'axe de la colonne, depuis les épaules et/ou le sommet du crâne),
• Engourdissement ou fourmillement des extrémités.
Réaliser une évaluation complète chez tous les patients :
• La fiabilité du patient est-elle questionnable ? (état mental altéré, patient non coopératif, intoxication),
• L'examen du rachis est-il anormal ?
• L'examen sensitif/moteur est-il anormal ?
NON
OUI
Envisager de ne pas procéder à la SMR si :
• Collission arrière simple (en voiture) ?
• Patient ambulatoire ?
• Absence de douleur cervicale ?
SMR
OUI
NON
PAS DE SMR
SELON JUGEMENT

9.2 Retrait du casque

PROCÉDURE

1. Si le patient est conscient, lui expliquer la procédure au patient.
2. Un premier intervenant se positionne derrière la tête du patient :
    - Stabiliser la tête et le cou en position neutre :
        - Appuyer ses paumes sur les côtés du casque
        - Tenir fermement les bords inférieurs du casque
3. Un deuxième intervenant se positionne à côté du patient :
    - Ouvrir ou retirer la visière si nécessaire.
    - Si présence de lunettes, les retirer.
    - Détacher et/ou couper la jugulaire du casque.
4. Saisir l'angle de la mandibule du patient avec trois doigts.
5. Placer une main sous le nuque du patient, au niveau de l'occiput.
6. Écarter les parties latérales du casque en le faisant tourner lentement.
    - Ne pas toucher le nez du patient.
7. Placer un coussin ou tout autre rembourrage sous la tête du patient pour la maintenir en position neutre dans l'axe.
8. Immobiliser le patient au moyen d'un collier cervical.

9.3 Évaluation de la tension (méthode palpatoire)

PROCÉDURE

1. Placez le patient avec le bras au niveau du cœur.
2. Palpez le pouls brachial ou radial.
3. Appliquez le brassard autour du membre.
4. Gonfler le brassard de pression artérielle à 30 mmHg au-dessus du point où le pouls disparaît.
5. Dégonfler lentement le brassard tout en notant la valeur à laquelle on sent que le pouls revient.
6. Enregistrer la pression artérielle systolique comme #/P.

9.4 Évaluation de la glycémie

PROCÉDURE

1. Préparer le matériel (glucomètre, lancette, lingettes désinfectantes, Band-Aid®, bandage de gaze et conteneur pour objets tranchants) à l'avance.
2. Effectuer une asepsie au moyen d’une lingette désinfectante, en laissant sécher pendant 30 secondes.
3. Allumer l'appareil.
4. Confirmer le code de la bandelette réactive avec la lecture de l'écran du glucomètre.
5. Piquez le doigt avec une lancette pour obtenir un échantillon de sang.
6. Appliquer l'échantillon sur la bandelette réactive.
7. Couvrir le point de ponction avec un pansement si le saignement continue.
8. Noter et enregistrer la lecture.

9.5 Ventilation par BAVU

PROCÉDURE

1. Sélectionner le BAVU de taille adulte, pédiatrique ou infantile et assembler les composants.
2. Fixer l'alimentation en oxygène au BAVU ; régler l'alimentation en oxygène au niveau recommandé.
3. Sceller le masque sur le visage du patient tout en maintenant l'inclinaison de la tête et l'élévation du menton.
4. Presser le ballon pour ventiler le patient.
5. Observez le soulèvement et l'abaissement du thorax à chaque ventilation. Si le thorax ne se soulève pas, réévaluer l'équipement, la technique et le patient.
6. Si deux secouristes sont disponibles, l'un d'eux utilise ses deux mains pour maintenir l'étanchéité du masque, tandis que le second comprime le ballon pour effectuer les ventilations.